

CDS

CUESTIONARIO DE DEPREDIÓN PARA NIÑOS

MANUAL

(4ª Edición revisada y ampliada)

INDICE

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
 - 1.1 FICHA TÉCNICA
 - 1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
 - 1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ESCALAS
 - 1.4 EL CDS Y LOS ADULTOS
 - 1.5 FINALIDAD Y APLICACIONES
 - 1.6 MATERIAL
2. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN
 - 2.1 INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN
 - 2.2 CORRECCIÓN Y OBTENCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS
3. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA
 - 3.1 ESTUDIOS ORIGINALES
 - 3.2 ADAPTACIÓN ESPAÑOLA
 - 3.3 SALUD MENTAL, DEPRESIÓN Y OTRAS VARIABLES DE LA PERSONALIDAD
4. NORMAS INTERPRETATIVAS
 - 4.1 MUESTRA GENERAL DE TIPIFICACIÓN
 - 4.2 CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS EN PUNTUACIONES TRANSFORMADAS
 - 4.3 GRUPOS CLÍNICOS
 - 4.4 BAREMOS ESPECÍFICOS

BAREMOS

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

Ha pasado más de una década desde que se terminó la adaptación y se publicó la primera edición del Manual (1983). El instrumento ha tenido una buena acogida y los usuarios han podido obtener información sobre

la depresión en niños y adolescentes, tanto en los aspectos globales (el positivo y el depresivo) como en los específicos (las 8 escalas), esas variables que pueden evaluarse con el Cuestionario de depresión para Niños (CDS).

La depresión es actualmente un constructo “alza”, su estudio y evaluación está llamando la atención de los investigadores españoles (y la someten a diversos controles experimentales) y de los profesionales yos profesionales que realizan una labor aplicada” (y la miden para usar los datos en tareas de consejo y solución de problemas).

Después es actualmente un constructo “en alza”, su estudio y evaluación está llamando la atención de os investigadores españoles (y la someten a diversos controles experimentales) y de los profesionales que realizan una labor “aplicada” (y miden para usar los datos en tareas de consejo y solución de problemas).

Después de aquellos primeros análisis (explicitados en varios apartados de este Manual), se ha estudiado la depresión infantil en nuevos y diversos ambientes. Principalmente han sido los profesionales universitarios los que han promovido dichos estudios.

Hemos conocido los trabajos que recientemente han realizado en Salamanca (María Soledad González Mateos y Antonio Sánchez Cabaco, Universidad Pontificia) y en Madrid (María Victoria del barrio, Universidad Nacional de Educación a Distancia), y hemos solicitado su colaboración para dar a conocer los resultados. Fruto de esto ha sido la introducción de un nuevo apartado en el capítulo 3 y una Bibliografía más amplia; el lector interesado puede encontrar en estas ampliaciones una mayor riqueza de fuentes que le faciliten una mejor comprensión del constructo y aprovechamiento de las medidas obtenidas con el CDS.

Aunque la fase de la adaptación (1983) está ya lejana en el tiempo, nos parece justo seguir reconociendo y agradeciendo aquellas diversas y valiosas colaboraciones, tanto desde los ambientes escolares como desde los clínicos.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 FICHA TÉCNICA

Nombre Original:	Childrens depression Scale (CDS)
Autores:	M. Lang y Tisher
Adapación española:	TEA
Administración:	Individual colectiva
Duración:	Variable entre 30 y 40 minutos
Aplicación:	8 a 16 años
Significación:	Evaluación global y específica de la depresión en los niños

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

En la revisión de la literatura sobre este tema, los trabajos de K. Abraham (1949), M. Klein (1934), B. Rank y otros (1951) y R. Spitz (1946), aluden a diferentes formas de la depresión infantil; además, varios autores citados por J. Anthony y P. Scott (1960) han descrito casos de psicosis maniaco-depresiva en la infancia.

Sin embargo, en los textos de psiquiatría infantil publicados hasta mediados os años sesenta, son raras las alusiones a la depresión en la infancia como algo distinto de la depresión y de la psicosis maniaco-depresiva en adultos; a partir de esos años ha aumentado considerablemente el interés y reconocimiento de este fenómeno en la infancia.

En principio, ha habido un cierto desacuerdo de tipo teórico sobre la validez del concepto de la depresión en la infancia. Algunos autores (como H. E.Rie 1966) definen la depresión en términos de un número de características psicopatológicas encontradas en los adultos, e indican que es teóricamente imposible su presencia en los niños. Otros sostienen que, aun cuando las manifestaciones clínicas de la depresión son similares en adultos y niños, las diferencias están en que en éstos no aparecen “aquellas formas de depresión que son consecuencia de procesos defensivos y restituidos más amplios y, en particular, de las introyecciones e identificaciones patológicas que caracterizan la depresión melancólica de tipo neurótico y psicótico”.

Poe otra parte, se han señalado distinciones entre las formas enmascarada y abierta de la depresión; al describir la primera, K. Glaser y M.Sperling están de acuerdo con J. M. Toolan en que los niños no presentan los síntomas de las reacciones depresivas de los adultos; en aquellos se encuentran problemas de conducta y de delincuencia, reacciones psiconeurosis tales como las fobias escolares, dificultades en el aprendizaje, berrinches de mal humor, tendencia a los accidentes, holgazanería, autodestrucción, alteraciones digestivas y en el sueño, dolores de cabeza de tipo migraña y deficiencias o retrasos motóricos.

En cuanto a la depresión abierta, E. Poznanski y J. P. Zrull (1970) observaron 14 niños que mostraban depresión afectiva, es decir, “la expresión de un estado afectivo de desgracia o tristeza crónicas...” También E. Frommer (1967), J. Sandler describen la depresión afectiva clínica; los dos últimos autores dividen su muestra de 84 niños según la edad (hasta siete, siete-diez, once-trece y catorce-dieciséis años) y señalan que las diferencias intergrupos son fundamentalmente cualitativas, mientras que las diferencias intragrupos son principalmente de tipo cuantitativo

J. Stack (1971) confirma la observación de E. Frommer (1967) de que la depresión en la infancia es un mal común que se manifiesta frecuentemente con la sintomatología somática. Como indica el segundo, “se debe sospechar la existencia de depresión en los niños que se quejan de malestares abdominales recurrentes no específicos, dolores de cabeza, problemas de sueño o temores irracionales, o presentan alteraciones de humor, tales como irritabilidad, llantos incomprensibles o explosiones asociadas a mal temperamento”. Stack prefiere hablar de depresiones en la infancia en lugar de considerar el fenómeno como una entidad única, e intenta clasificar sus formas de la manera siguiente:

- **Grupo 1**, depresiones en niños preescolares:
 - a) Hiperactividad
 - b) Apatía
 - c) Somatización
- **Grupo 2**, depresiones en niños escolares
 - a) Depresión simple

- b) Fobias u obsesiones con reacciones depresivas
- c) Estados depresivos mixtos
- d) Depresiones asociadas con síndromes cerebrales orgánicos y estados psicóticos.

Y en estos grupos el autor ha aplicado separadamente drogas psicótropas

También se encuentran alusiones a las características somáticas de la depresión en la infancia en los trabajos de W. Ling y colaboradores (1970) y de V. Kuhn (1971). Y este considerable aumento del interés por el tema puede estar ejemplificado por el IV Congreso de la Unión de Paidopsiquiatras celebrado en (1971) y las Conferencias sobre la Depresión en la infancia (1975) promovidas por el Centro de Estudios sobre el Niño y la Salud Mental del Instituto nacional de Salud Mental (editadas por Schilterbrandt y Raskin 1977)

Por otra parte, los informes sobre la frecuencia de dicha depresión varían mucho. Kuhn (1971) señala que “actualmente muchos investigadores bien conocidos afirmarían que, en cualquier grupo promedio de niños tratados por un psiquiatra infantil, se puede esperar alrededor de un 12% de casos con perturbaciones patológicas clasificables en esa línea”. Cuando Lefkowitz (1977) hace una revisión de la literatura sobre el tema observa que, en los estudios epidemiológicos de conductas desviadas en niños, un 20% de la población infantil parece presentar los síntomas de problemas depresivos observados normalmente en muestras clínicas. Más aún, en un estudio longitudinal de más de 50 niños, desde el nacimiento a la edad escolar, Meierhofer (1971), las principales razones de la amplia variedad de frecuencias citadas se debe fundamentalmente a que entre los investigadores hay divergencias en el significado del concepto de depresión y a la diversidad de las muestras estudiadas.

Esta considerable confusión en la literatura sobre el concepto y la presencia de la depresión en la infancia, viene a señalar la necesidad de un método sistemático, estructurado y aplicable para medir dicha entidad, lo cual ha sido señalado por el Subcomité de Evaluación dirigido por Kovacs y encargado de investigar la medida de la misma. La misma Kovacs y A. T. Beck (1977) han intentado ampliar la aplicabilidad del BDI (Beck depression Inventory, diseñado para adultos) a muestras de niño y realizado un estudio piloto. Con esta excepción, en el momento de diseñar el CDS no se conocía ningún otro intento de medida escalara para investigar la depresión en la infancia, o por lo menos no se había publicado ningún test en esta línea.

La presente Escala de Depresión para Niños (CDS) difiere del trabajo de Kovacs-Beck en que no ha sido elaborada a partir de un test para adultos; se ha diseñado específicamente para los niños.

Y ha tenido en cuenta lo recientemente señalado por los mismos Kovacs-Beck y por A. Nowells (1977): el hecho de que tienen mucha importancia las observaciones de las personas que rodean y conocen al niño (los otros significativos), tales como los padres y los profesores; aunque el CDS está destinado a los niños, la misma escala, con ligeras modificaciones de formato, puede ser contestada por un familiar, profesor u otro significativo que responda según su conocimiento del niño.

A pesar de la citada confusión en la literatura, las autoras del DCS creen que dicha depresión es una respuesta humana normal que varía en intensidad u cualidad, que se encuentra en la población infantil y que juega un papel especial en muchos grupos psiquiátricos, incluyendo los diagnosticados como depresiones neuróticas o psicóticas.

¿Es un estado o un síndrome? Las diferentes características aludidas en los trabajos sobre la sintomatología de la depresión en la infancia podrían resumirse en:

- **Respuesta afectiva:** sentimientos de tristeza/ desgracia y llantos

- **Autoconcepto negativo:** sentimientos de inadecuación, poca autoestima, inutilidad, desamparo, desesperanza y falta de cariño.
- **Disminución de la productividad mental y de los impulsos:** aburrimiento, alejamiento, falta de energía, descontento, poca capacidad para el placer y para aceptar la ayuda o el confort, así como retraso motor.
- **Preocupaciones:** por la muerte, la enfermedad, el yo o los otros, así como pensamientos suicidas y sentimientos de pérdida (real o imaginaria)
- **Problemas de agresión:** irritabilidad y explosiones de mal humor.

Estas características se tomaron como conceptos operativos para definir la entidad que intenta evaluar el CS, y se elaboraron elementos pertinentes a todos ellos: en su construcción se tuvieron en cuenta los contenidos de los informes psiquiátricos, las historias recogidas en el TAT y las hojas de respuesta de tests de frases incompletas de niños con depresión, así como las descripciones de las experiencias y fenómenos depresivos presentadas en la literatura. En la redacción se intentó describir dichas experiencias de modo que fueran reconocidas por los niños si de alguna manera las poseían, y fue depurada por una muestra de niños en tratamiento, a los que se pidió que comentaran o modificaran dicha redacción y sugirieran nuevas frases según sus experiencias.

El resultado final fue una escala con 66 elementos, entre los que hay 18 **positivos** (como “Me siento alegre la mayor parte del tiempo”) y 48 **depresivos** (como “me siento solo muchas veces”). Los elementos positivos están entremezclados con los depresivos, para reducir una tendencia halo en respuestas, y para medir la “incapacidad para experimentar placer o diversión” como un componente de la depresión; también se procuró que presentaran una variación tal que, al ser contestados por el niño, no le afectaran de un modo depresivo.

Con la ayuda de criterios teóricos y lógicos, los 66 elementos se agruparon en subescalas, intentando que cubrieran muchas de las características de la depresión en los niños, y en realidad estas subescalas son similares a los conceptos incluidos en la definición dada en los párrafos anteriores; también se procuró que las escalas tuvieran igual número de elementos.

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ESCALAS

El Cuestionario CDS contiene 66 elementos, 48 de tipo depresivo y 18 de tipo positivo. Estos dos conjuntos se mantienen separados y permiten dos subescalas generales independientes: **Total Depresivo** y **Total Positivo (TD y TP)**

Dentro de cada una de estas dos dimensiones se agrupan sus elementos por el contenido de los mismos en varias subescalas, que podría describirse brevemente de la siguiente manera:

1. **Total depresivo**, con seis subescalas:

- **RA; Respuesta Afectiva** (ocho elementos), alude al estado de humor de los sentimientos del sujeto
- **PS, Problemas sociales** (ocho elementos), se refiere a las dificultades en la interacción social, aislamiento y soledad del niño
- **AE, Autoestima** (ocho elementos), se relaciona con los sentimientos, conceptos y actitudes del niño en relación con su propia estima y valor.

- **PM, reocupación por la muerte/salud** (siete elementos), alude a los sueños y fantasías del niño en relación con su enfermedad y muerte.
- **SC, Sentimiento de culpabilidad** (ocho elementos), se refiere a la autopunición del niño.
- **DV, depresivos varios** (nueve elementos), incluye aquellas cuestiones de tipo depresivo que no pudieron agruparse para formar una entidad.

2. **Total Positivo**, con dos subescalas:

- **AA, Ánimo – alegría** (ocho elementos, puntuados en el polo opuesto), alude a la ausencia de alegría, diversión y felicidad en la vida del niño, o a su incapacidad para experimentarlas.
- **PV, Positivos varios** (diez elementos, puntuados en el polo opuesto), incluye aquellas cuestiones de tipo positivo que no pudieron agruparse para formar una entidad.

Para estas subescalas son muy interesantes para poder especificar e interpretar una determinada puntuación total depresiva o positiva, puesto que los niños pueden manifestar su depresión de muy diferentes maneras.

1.4 EL CDS Y LOS ADULTOS

Los elementos del CDS pueden ser redactados cambiando (en la mayoría de los casos) el sujeto de la oración, de primera a tercera persona, y contestados por un adulto que conozca al niño con problemas depresivos. Así, por ejemplo, “Me siento solo muchas veces” puede redactarse como “El (niño) se siente solo muchas veces”, o bien incluyendo el nombre del mismo niño: “Luis se siente solo muchas veces”

Este CDS así redactado puede ser utilizado para obtener de los adultos que conocen al niño (padres, familiares, profesores, etc.) otra visión de los aspectos depresivos del niño. El obtener esta multiplicidad de información sobre el sujeto es una práctica corriente. En algunos estudios, como en la Escala Vineland de madured Social y en la Guía Bristo de Adaptación Social (1974), se examinan sistemáticamente las respuestas de padres y profesores, y no buscan en el niño esta misma información; sin embargo, si el CDS contestado por el mismo niño se complementa con la información obtenida por” otros significativos” para el sujeto, todo el conjunto de datos puede ser utilizado para obtener un índice de datos puede ser utilizado para obtener un índice más fiable y comprensivo que el uso de una sola fuente de información sobre el sujeto.

Más aún, se puede obtener otra información importante sobre el niño y su familia examinando cualitativamente cualquier diferencia existente entre las puntuaciones obtenidas en el CDS por el padre y por la madre, y entre las de éstos y las el sujeto; en este examen puede, incluso, ser valioso profundizar hasta unos específicos elementos en los que se observen diferencias significativas.

1.5 FINALIDAD Y APLICACIONES

El CDS es aplicable a niños comprendidos entre los ocho y dieciséis años, es decir, a sujetos que puedan comprender el contenido de los elementos. No presenta problemas la falta de una buena capacidad lectora, puesto que los elementos, en la mayoría de los casos, son leídos en voz alta por el examinador; en algunas ocasiones

puede ser conveniente que el sujeto mismo lea las cuestiones en solitario y conteste en la Hoja de respuestas, como ocurre cuando el CDS es contestado por los adultos significativos para el niño.

En la versión original australiana, los elementos se presentan en pequeñas tarjetas de distintos colores (uno para cada subescala, lo cual permite la corrección y puntuación), y la persona que responde las sitúa en montones diferentes según su grado de acuerdo o desacuerdo con su contenido. Este formato dificulta la aplicación del CDS en forma colectiva, pero puede ser interesante en algunos casos clínicos; sólo se tiene a la vista un elemento y el sujeto se ve menos influenciado por el contenido de alguno anteriormente contestado, hay una manipulación activa y física de la tarjeta, se introduce un aspecto lúdico manipulativo y, con todo ello, es menos probable una tendencia o halo en las respuestas.

Su aplicación está indicada en todos los casos en que se sospeche la depresión. Como se ha señalado anteriormente, hay muchas características que han mostrado relación consistente con la depresión en la infancia: el niño parece o es visto como triste, desgraciado, lloroso, aburrido, aislado, apático, con dificultades sociales, con problemas psicosomáticos (dolores de cabeza, quejas abdominales, dificultades en el sueño, etc.), poca autoestima, sentimientos de inutilidad, sensación de no ser querido, preocupación por la salud o la muerte, manifestaciones anómalas de la agresividad, etc. Puede ser aconsejable cuando se tenga noticia de otros indicativos tales como una gran privación, una pérdida de una persona importante para él, un bajo rendimiento escolar, una enfermedad física o una ruptura familiar.

Las autoras del CDS recomiendan que, además del niño, sean también ambos padres los que contesten al Cuestionario y, si es posible, se obtengan datos de algún otro adulto significativo para el sujeto; y cuando éste tenga hermanos en edades comprendidas entre los ocho y los dieciséis años, puede ser valioso obtener las respuestas de éstos al CDS preparado para adultos (en tercera persona), e, incluso, sus mismas respuestas al Cuestionario como sujetos de examen (en primera persona). Frecuentemente se ha observado que la depresión está presente como un problema de la familia y sus miembros interactúan depresivamente; en estos casos el fenómeno no está sólo en el niño y el examen y terapia debería incluir a toda la familia.

En un proceso terapéutico, el CDS puede facilitar la comunicación del sujeto; con sus elementos el niño expresa sus experiencias íntimas, probablemente con más libertad que en una comunicación directa. Por otra parte, al encontrar la redacción de los elementos el niño comprueba que sus sentimientos y actitudes no son un caso único. En estas situaciones, cuando el CDS se utilice como instrumento terapéutico, el psicólogo puede modificar a su juicio las instrucciones de aplicación del Cuestionario, conceder más tiempo, conversar sobre algunos elementos, compartir con el niño el procedimiento de corrección y puntuación u ofrecerle la oportunidad de cambiar alguna respuesta.

Finalmente, el CDS puede utilizarse en la docencia universitaria o en un curso de entrenamiento específico de psicodiagnóstico para proponer una definición comprensiva de la depresión en los niños o para introducir una estructura conceptual sobre la misma; además, el lenguaje del niño para expresar estos sentimientos, puesto que los elementos están redactados con ese mismo lenguaje.

1.6 MATERIAL

Aparte del presente Manual (con las bases teóricas, la descripción de las escalas, las normas de aplicación e interpretación y la fundamentación estadística), es necesario el material siguiente:

a) Aplicaciones colectivas:

- Hojas de respuestas
- Plantillas de corrección

b) Aplicaciones individuales

- 66 tarjetas con la redacción de los elementos y cinco tarjetas de clasificación; no es necesaria plantillas de corrección.

Para poder acoplar una sola Plantilla a la Hoja de respuestas, diseñada para las ocho subescalas del CDS, hubo necesidad de reordenar los 66 elementos originales, así como trasladar la subescala Ánimo-alegría al principio de la Plantilla; de este modo, os sujetos comienzan con una redacción de tipo positivo, puesto que la mayoría del CDS es de tipo negativo. En el cuadro que viene a continuación se indica la correspondencia entre la ordenación española (Esp.) y la original (Aus.), y la escala (Esc.) en que puntúa cada elemento.

Es posible introducir la mecanización en los procesos de corrección, puntuación e interpretación, pero exige la utilización de una Hoja de respuestas de diseño y material especial que pueda ser tratada mediante una lectura óptica; el procedimiento es desaconsejable cuando los niños son muy pequeños y no pueden anotar sus contestaciones con la precisión que exige el sistema de mecanización.

CUADRO 1

Correspondencia entre las versiones españolas y australiana y la escala puntuada

Esp.	Aus.	Esc	Esp.	Aus.	Esc	Esp.	Aus.	Esc	Esp.	Aus.	Esc
1	1	AA	17	8	AA	33	24	AA	49	65	AA
2	7	RA	18	27	RA	34	33	RA	50	51	RA
3	16	PS	19	20	PS	35	40	PS	51	56	PS
4	9	AE	20	25	AE	36	38	AE	52	53	AE
5	12	PM	21	14	PM	37	30	PM	53	60	PM
6	21	SC	22	37	SC	38	46	SC	54	55	SC
7	3	DV	23	6	DV	39	43	DV	55	59	DV
8	5	PV	24	15	PV	40	29	PV	56	34	PV
9	2	AA	25	22	AA	41	41	AA	57	66	AA
10	10	RA	26	32	RA	42	45	RA	58	54	RA
11	18	PS	27	28	PS	43	49	PS	59	64	PS
12	19	AE	28	35	AE	44	52	AE	60	58	AE
13	13	PM	29	26	PM	45	48	PM			
14	23	SC	30	39	SC	46	47	SC	61	61	SC
15	4	DV	31	42	DV	47	50	DV	62	62	DV
16	11	PV	32	17	PV	48	31	PV	63	36	PV
									64	44	PV
									65	57	PV
									66	63	DV

2. NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN

2.1. INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

El CDS es, idealmente, un instrumento de aplicación individual; el niño sentado a la mesa frente al examinador. En esta situación es más probable que el sujeto se sienta más confortable y animado a compartir sus experiencias y sentimientos con el examinador (lo cual redundará en unas respuestas más válidas); además, se pueden recoger observaciones sobre conductas no verbales en el desarrollo de la aplicación.

Cuando se trate de aplicar la prueba a uno o varios miembros de la familia o conocidos del niño, es más aconsejable que todos estén en la misma sala y al mismo tiempo, aunque con espacio suficiente para que actúan y

contesten independientemente. De esta manera, una vez completado el cuestionario, pueden compartir sus observaciones sobre el niño y analizar sus diferencias al enfocar el problema del sujeto.

En el caso de una aplicación a un grupo de sujetos, hay que procurar que el mismo tenga una naturaleza homogénea (alumnos de una misma clase, grupo de psicoterapia, etc.), y sea poco numeroso, para facilitar un buen clima de aplicación y sinceridad. Aunque, en general, las cuestiones del CDS están redactadas en forma afirmativa, hay muchas que tienen carga o significado negativo (“a menudo creo que valgo poco”, y el examinador debe lograr la cooperación de los niños para evitar una actitud sistemática de rechazo de lo negativo.

El CDS pide unas respuestas directas del sujeto sobre sus sentimientos, pensamientos y conductas por tanto, la validez del instrumento depende de la apertura y sinceridad con que el niño responde a las cuestiones, y estas características están, a su vez, relacionadas con el clima logrado entre examinador y examinado. Por otra parte, dado que el CDS tiene la capacidad de llegar hasta la depresión del niño, tiene también implicaciones terapéuticas; se ha observado que muchos niños, que tenían dificultades para verbalizar sus experiencias o sentimientos, encontraban mucha ayuda en el hecho de que estos fuertes sentimientos estaban ya redactados para ellos, que habían sido tenidos por otros niños y que no era malo expresarlo; consecuentemente, todo ello facilita su apertura y sinceridad.

Las autoras coinciden que el CDS sea introducido a los examinados de una manera amistosa y sin prisas. Las instrucciones verbales que vienen a continuación deben ser tomadas sólo como una guía para la aplicación, y el examinador debe utilizar su juicio para adecuarlas a la situación y sujetos concretos.

Una vez que los sujetos disponen de una Hoja de respuestas y que se han anotado en la cabecera los datos de identificación, se puede decir:

“Otros niños han contestado a las frases que voy a leer, diciendo cómo piensan o cómo sienten, si están de acuerdo o no sobre lo que se dice en esas frases. Solo veré las contestaciones para conocer vuestros problemas.

Yo leeré un número y una frase, y vosotros contestáis en la Hoja que tenéis delante, poniendo una marca sobre uno de los redondelitos que hay después de ese número. Para que veáis cómo se contesta voy a poner un ejemplo en la pizarra”

Se copia en el encerado la redacción del ejemplo y los lugares destinados a la respuesta, con el siguiente contenido

“75. Me gustan las visitas a los museos 75.

++	+	+/-
—	—	—
○	○	○

Cuando, durante el desarrollo el examen, surja alguna pregunta, el examinador puede contestarla de forma que no influya en el resto de la prueba ni en los demás examinados. Casi siempre es suficiente contestar con un: “simplemente intenta contestar según lo que sientes o piensas en este momento sobre la frase”

Una vez terminada la lectura de los elementos, se recogerán las Hojas de respuestas comprobando si cada niño ha contestado a todas las frases y están anotados los datos de cabecera; en caso contrario, conviene pedir al niño que cumplimente éstos y, si hubiera elementos dejados en banco, se le pueden volver a leer las frases correspondientes para que las conteste.

Mediante el uso de los elementos impresos en tarjetas separadas, se puede realizar mejor una aplicación individual. Una vez ordenadas las tarjetas por el número impreso en el ángulo inferior izquierdo y sentado el niño a la mesa, con espacio suficiente en ella, se sitúan en fila las tarjetas de clasificación. **Muy en desacuerdo, En desacuerdo, No estoy seguro, De acuerdo y Muy de acuerdo**, al lado de las cuales el niño podrá ir colocando las tarjetas-elementos según su contestación a su contenido.

Al lado mismo del niño se colocará el montón de tarjetas con los elementos y, como en el caso de la aplicación colectiva, se indicará:

“Otros niños han contestado a las frases que tienen estas tarjetas, para decir cómo piensan o cómo sienten, si están de acuerdo o no con lo que se dice en ellas. Vas a tomar una tarjeta y leer lo que dice. Si estás muy de acuerdo con eso, como ++, colócala al lado de esta otra tarjeta (SEÑALAR); si estás de acuerdo, como +, colócala al lado de esta otra (SEÑALAR); si estás muy en desacuerdo, como --, con ella, colócala aquí (SEÑALAR); si estás en desacuerdo, como -, colócala aquí (SEÑALAR). Si no estás seguro entre estar de acuerdo o en desarrollo, como si fuera algo entre + y - colócala aquí (EN EL CENTRO DE LA FILA DE MONTONES)”

Si el examinador lo considera apropiado, puede preguntarle al niño si prefiere leer las frases él mismo, o que le sean leídas. Este examen individual es muy apropiado para recoger observaciones y datos sobre la conducta del niño durante el examen. Estas mismas tarjetas pueden ser utilizadas para las aplicaciones a adultos que conocen bien al niño, pidiéndoles que formen los montones considerando el contenido de la tarjeta como referido al niño.

2.2 CORRECCIÓN Y OBTENCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DIRECTAS

Cada elemento se puntúa en una escala de 1 a 5 puntos en la dirección del rasgo de la depresión, desde **Muy en desacuerdo a Muy de acuerdo** en los elementos de tipo depresivo, y desde **Muy de acuerdo a Muy en desacuerdo** en los tipos positivos. Con esta inversión en los positivos (subescalas AA y PV) se logra que todos ellos apunten hacia el rasgo de la depresión.

Para facilitar esta tarea de puntuación en las contestaciones recogidas en la Hoja de respuestas, se ha diseñado una Plantilla de corrección que permite obtener las puntuaciones directas de todas las subescalas y anotarla en el margen derecho de la Hoja. Se colocará la Plantilla sobre ésta de modo que por los circuitos existentes en el margen izquierdo de la Plantilla aparezcan los números 1 y 25. Este momento, los recuadros alargados que hay dentro de la Plantilla dejarán ver los elementos pertenecientes a la primera subescala de puntuación (5 a 1); se contarán los puntos obtenidos por los elementos de AA. Obsérvese que no se incluyen los recuadros de la Plantilla señalados con círculos y numeración 64, 65 y 66 de la base de la misma (puesto que no pertenecen a la subescala AA). Como se indica en la parte superior de la Plantilla, es necesario restar este valor de 48; es decir, la puntuación directa es $AA = 48 - \text{suma de puntos obtenida}$. Esta puntuación se anotará en el primer recuadro del margen derecho de la Hoja, señalado con las siglas AA.

A continuación se desliza un poco hacia abajo la Plantilla hasta que por los circuitos del margen izquierdo aparezcan los números 2 y 26. En este momento los recuadros alargados dentro de la Plantilla dejarán ver los elementos respuestas de la subescala RA. Se suman los puntos obtenidos y su resultado se anotará en la segunda casilla del margen derecho de la Hoja (RA).

Se vuelve a deslizar la Plantilla hacia abajo y se tendrá:

- Núms. 3 y 27, subescala PS, 8 elementos
- Núms. 4 y 28, subescala AE, 8 elementos
- Núms. 5 y 29 subescala PM, 7 elementos (por esto queda en blanco el último recuadro alargado de la Plantilla)
- Núms 6 y 30 subescala SC, 8 elementos
- Núms. 7 y 31, subescala DV, 9 elementos (incorpora el señalado como 66 en la base)

- Núms 8 y 32, subescala PV, 10 elementos (incorpora los señalados como 64 y 65 en la base). Como se indica en la parte superior de la Plantilla, es necesario restar este valor de 60; es decir, $PV = 60 - \text{suma de puntos}$.

Una vez anotadas las puntuaciones directas de las ocho subescalas en el margen derecho de la Hoja, se procede a obtener las dos dimensiones superiores, Total Positivo y Total Depresivo, de la siguiente forma:

$$TP = AA + PV$$

$$TD = RS + PS + AE + PM + SC + DV$$

Y los resultados de estas operaciones se anotan en sus casillas.

En el caso de una aplicación individual (con tarjetas), el corrector tendrá construido previamente un cuadro con seis columnas y 10 filas, algo así como:

	+	+	+	+/-	-	- -						
2. RA	=	5 ()	+	4 ()	+	3 ()	+	2 ()	+	1 ()	=	
3. PS	=	5 ()	+	4 ()	+	3 ()	+	2 ()	+	1 ()	=	
4. AE	=	5 ()	+	4 ()	+	3 ()	+	2 ()	+	1 ()	=	
5. PM	=	5 ()	+	4 ()	+	3 ()	+	2 ()	+	1 ()	=	
6. SC	=	5 ()	+	4 ()	+	3 ()	+	2 ()	+	1 ()	=	
7. DV	=	5 ()	+	4 ()	+	3 ()	+	2 ()	+	1 ()	=	_____
Total depresivo: TD... .. =												
1. AA	=	1 ()	+	2 ()	+	3 ()	+	4 ()	+	5 ()	=	
8. DV	=	1 ()	+	2 ()	+	3 ()	+	4 ()	+	5 ()	=	_____
Total Positivo: TP =												

A continuación tomará el montón de tarjetas colocadas por el niño al lado de la tarjeta “++” y las distribuirá en varios submontones, de acuerdo con la escala en la que puntúan, señalada con sus letras en el ángulo inferior derecho de la tarjeta. Se contará el número de tarjetas de cada subescala y estos valores se introducirán entre los paréntesis que aparecen frente a cada escala del cuadro anterior, debajo del símbolo “++”

Se hará lo mismo con el montón de tarjetas colocadas por el niño junto a la tarjeta “+” y una vez clasificado según las subescalas se anotarán las frecuencias o existencias los respectivos paréntesis, bajo el símbolo “+”. Igualmente se procederá con los otros tres montones: “+/-”, “-”, y “- -” y los resultados se anotarán en el cuadro.

Luego, se procederá a resolver las operaciones anotadas; así, por ejemplo, para 2. RA se harán las multiplicaciones y sumas:

$$2. RA = 5(n1) + 4(n2) + 3(n3) + 2(n4) + 1(n5)$$

Siendo n el número de respuestas anotadas en cada una de las 5 columnas de paréntesis y el resultado es la puntuación directa en Ra y se anota en el margen derecho del cuadro, después del signo =.

Se hace la misma operación en cada una de las 8 filas para obtener las puntuaciones de todas las subescalas. El **Total Depresivo** es la suma de la seis subescalas primeras. El **Total positivo** es la suma de las dos últimas.

Una vez obtenidas las puntuaciones directas (en a aplicación colectiva o en la individual), se puede pasar a la fase de la interpretación (capítulo 4)

3. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA

3.1 ESTUDIOS ORIGINALES

EN el momento de la aparición del CDS, el manual original (1978) incluía un estudio de fiabilidad y validez utilizando una muestra experimental (N = 40) de niños con depresión, otra de control (N = 37) de niños normales, equiparables a los experimentales de edad, sexo y escolaridad, y una tercera muestra de 19 niños con diversos problemas de tipo clínico. Para formar el grupo experimental se utilizaron los siguientes criterios:

- El niño no asistía al colegio o había faltado continuamente más de un mes
- Durante las horas de clase estaba en casa con sus padres
- No existía un diagnóstico de enfermedad física/orgánica (no se consideraron excluyentes os casos con síntomas psicosomáticos, como los dolores de cabeza),
- Durante, al menos, dos semanas se había intentado (psicólogo, asistente social, etc.) y sin éxito, su vuelta al colegio.

En años posteriores (1980, 1981) se han analizado otras muestras de niños australianos (N = 60 y N = 182) y japoneses (N = 389), y actualmente se están llevando a cabo investigaciones y adaptaciones es otras lenguas y países (Italia, Francia, Alemania e India, además de España)

En las muestras originales se ha observado una buena fiabilidad y consistencia interna; se ha obtenido un coeficiente alfa de Cronbach de 0,96, y en una correlación test-rete de 0,74

Se ha llevado a cabo análisis de validez de contenido (utilizando, con anterioridad a la edición del Cuestionario, el criterio y discriminación de una muestra de niños con depresión y el juicio de siete psiquiatras infantiles), de validez concurrente (relaciones con el Cuestionario de personalidad CPQ de Cattell y capacidad discriminativa con un criterio de “infelicidad”), de validez de constructo (mediante análisis de diferencias entre los grupos experimental, control y clínico), y de validez factorial.

En estos estudios se ha ido comprobando, a la espera de más análisis de revalidación, la precisión, valor y capacidad discriminativa del CDS para medir la depresión en los niños. Así, por ejemplo, se ha mostrado que la personalidad de los sujetos con estos problemas presentan una personalidad con las siguientes características medidas con el instrumento de Cattell:

- A-: Reservado, alejado, crítico, frío
- C-: Afectado por los sentimientos, emocionalmente poco estable, turbable
- D+: Excitable, impaciente, exigente, hiperactivo, no inhibido
- E-: Sumiso, obediente, dócil. Acomodaticio, cede fácilmente
- F -: Sobrio, prudente, serio, taciturno, se autodesaprueba

- G-: Despreocupado o desatento con las normas, actúa por conveniencia propia
- H-: Cohibido, tímido, sensible a la amenaza
- I+: Sensibilidad blanda, impresionable, dependiente, superprotegido, evita la amenaza física
- J+: Dubitativo, irresoluto, reservado, individualista, precavido, reprimido interiormente
- O+: Apreensivo, con sensación de culpabilidad, inseguro, preocupado, turbable con reproches
- Q₃-: Poca autoestima, sigue sus propias necesidades, incontrolado
- Q₄+: tenso, frustrado, presionado, sobreexcitado, inquieto
- Introvertido QII-
- Ansioso QI +
- Inestable (Neuroticismo +)

Estas observaciones fueron tomadas del análisis de las relaciones entre el CDS y el CPQ en una muestra de 77 niños, cuyos principales índices se recogen en la tabla 1, y que, en cierto modo, fueron replicados con el estudio de niños japoneses (N = 190) con el Cuestionario EPQ-J de Eysenck, cuyos índices se incluyen en la tabla 2.

Este perfil de personalidad es muy consistente con los aspectos indicados en la literatura como propios de la depresión en los niños: las escalas C y J del CPQ apuntan al área de la respuesta afectiva Q₃ a una autoconcepción negativa. F y H a un autoaislamiento y retraso motor, y D y Q₄ a las dificultades con la agresión. En cuanto a las dimensiones superiores de la personalidad (ansiedad, extraversión y Neuroticismo), los índices encontrados vienen a mostrar que, aunque el CDS mide un fenómeno relativamente independiente, está bastante relacionado con los factores generales de la personalidad.

En otro estudio sobre 40 niños, éstos fueron clasificados por el personal clínico que los trataba (y que los conocía bien) en un continuo de siete puntos (desde feliz a infeliz), y dicotomizados por la mediana de sus puntuaciones en el CDS; el análisis diferencial de las frecuencias mostró una clara relación entre las puntuaciones altas en el CDS y la clasificación de “infeliz” dada por los clínicos (el 82,50% de los casos estaba bien evaluado con el CDS).

En cuanto a los análisis de validez de constructo se emplearon los grupos indicados al principio de este apartado (experimental, control y clínico) para examinar si las diferencias podían apuntar a la presencia del constructo evaluado. Efectivamente, en todas las escalas y subescalas se observaron diferencias significativas que apuntaban en la dirección esperada.

Tabla 1

Correlaciones (en centésimas) entre la puntuación Total de Depresión y las escalas del CPQ de Cattell

Escala	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	O	Q ₃	Q ₄	Ans.	Ext.	Neur.
Índice	-49	-11	-28	38	-27	-19	-33	-48	29	38	34	-25	46	48	-47	45

Tabla 2

Correlaciones (en centésimas) entre las subescalas y totales del CDS y las escalas del EPQ-J

Escala	RA	PS	AE	PM	SC	DV	TD	AA	PV	TP
N	60	49	54	54	36	54	64	32	26	33
E	-27	-27	-16	-15	-04	-09	-21	-48	-44	52
P	17	16	17	25	18	10	20	16	03	11
S	14	03	16	16	15	16	16	31	16	27

Nota. En el apartado 1.3 se encuentra el significado de las siglas en las escalas del CDS; en e EPQ-J son: Neuroticismo o Inestabilidad, Psicoticismo o Dureza y sinceridad (el polo opuesto de la escala L usada en los estudios originales)

Finalmente, tomando cada elemento como una variable, se analizó su capacidad discriminativa para diferenciar los tres grupos indicados, así como su composición factorial:

- La mayoría de los elementos discriminaban bien entre los grupos experimental control
- La primera dimensión general del análisis factorial (32% de la varianza total, un elevado porcentaje en esta área de la conducta) tienen saturación en la mayoría de os elementos (en 56 de ellos supera el índice de 0,40), y esto parece apuntar a una buena validez de elementos para medir esa dimensión o factor general.

Además, como en la mayoría de los casos se disponía del CDS contestado por un adulto significativo para el niño se analizaban las diferencias y similitudes y todos los resultados añaden nueva evidencia de la fiabilidad y validez del instrumento. Igualmente se ha estudiado la incidencia de las variables edad, sexo y estatus socioeconómico y, en general, aunque las muestras eran pequeñas, dichas variables no parecen influir significativamente. Algunos de estos análisis han ido replicados con muestras españolas y el lector puede consultar con muestras españolas y el lector puede consultar el apartado siguiente; en la tabla 3 pueden compararse los estadísticos de la primera muestra de control de las autoras, otra muestra de niños australianos, otra de niños japoneses y los de la adaptación española.

Tabla 3
Estadísticos de diferentes muestras

Escala	Original		Niños australianos				Niños japoneses				TEA	
	37 V + M		88 V		102 M		195 V		194 M		843 V + M	
	Media	D.t.	Media	D.t.	Media	D.t.	Media	D.t.	Media	D.t.	Media	D.t.
RA	17,4	6,0	22,10	6,44	21,19	5,81	16,50	4,12	18,15	5,63	19,05	6,11
PS	17,4	6,9	23,88	6,93	23,48	6,38	19,31	4,74	19,74	5,00	21,00	6,24
AE	21,2	7,2	24,92	7,18	25,50	6,16	23,12	5,98	24,96	5,68	22,45	6,21
PM	16,1	4,9	20,25	5,46	20,58	5,01	16,63	3,90	16,22	4,27	19,21	5,24
SC	20,4	7,0	24,92	6,20	25,30	6,11	21,63	4,13	21,94	4,30	25,97	5,98
DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,99	5,60
TD	116,9	35,3	145,77	32,20	144,16	27,91	123,14	21,42	127,60	24,77	138,51	27,79
AA	16,0	4,8	17,28	5,13	17,83	5,09	24,44	4,90	24,10	4,57	17,48	4,37
PV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,51	5,26
TP	41,5	8,9	40,60	8,95	40,45	9,49	54,99	7,78	54,25	7,57	40,01	8,28

3.2 ADAPTACIÓN ESPAÑOLA

Los primeros contactos con los autores y editores originales (Australia) e iniciaron a finales de 1979 y la adaptación se comenzó a mediados de 1980. El CDS se editó para su aplicación a los niños de forma colectiva; es decir, se dejó para otra ocasión preparar una versión de los elementos impresos en tarjetas separadas para cada uno; se diseñó una Hoja de respuestas que recogiera todas las contestaciones a los 66 elementos y se dispuso de forma que permitiera la utilización de una única plantilla de corrección para todas las subescalas y que obviara al corrector la tarea de tener que invertir el sentido de la puntuación en algunas subescalas (AA y PV). Este nuevo diseño fue entusiásticamente aceptado por la autoras y no ha presentado problemas en el casi millar de aplicaciones realizadas en la adaptación española.

Las aplicaciones colectivas para obtener la muestra de análisis y tipificación, los elementos fueron leídos en voz alta a los sujetos y éstos contestaban sobre la Hoja de respuestas en una escala de cinco puntos:

- ++ Muy de acuerdo
- + De acuerdo
- +/- No estoy seguro
- En desacuerdo
- - Muy en desacuerdo

Esta escala y símbolos fueron tomados del estudio original, excepto que en el punto intermedio (No estoy seguro) se cambió el símbolo “?”, pensando que con el “+/-“ se definía mejor la posición comprendida entre el Sí y el no, o entre el acuerdo y desacuerdo. Como en el estudio original, esas categorías han sido valoradas en una escala de 5 a 1 puntos.

En el momento de cerrar la recogida de casos para la tipificación (no para los análisis, pues éstos continúan actualmente), la muestra general contenía más de 900 sujetos de edades comprendidas entre los ocho y los catorce años, y procedían de muy diferentes partes de España y de colegios y centros especiales diversos.

A. ANÁLISIS DE ELEMENTOS

En una muestra de 843 niños de ocho a catorce años (26% mujeres), se tomaron únicamente los 730 que habían contestado a todos los elementos, y en ellos se analizaron los índices de atracción de cada elemento en la dirección que puntúa hacia la depresión (es decir, invirtiendo la escala en los elementos de tipo positivo, los de las escalas AA y PV). EN la tabla 4 se presentan esos índices, agrupados por escalas, y con un resumen promedio y puntuación directa media de la base. Los índices más bajos se encuentran en las escalas AA y PV; como éstas se puntúan invirtiendo la escala, parece que los niños se sienten más atraídos por los elementos que señalan aspectos positivos (3,83 y 3,75, respectivamente en la escala de 1 a 5). Dentro de los aspectos depresivos, los elementos más atractivos son los de DV (Depresión varios) y los de SC (Sentimientos de culpabilidad), y los menos atractivos son los RS (Respuesta afectiva). Este esquema de tipo de respuestas parece lógico en niños normales; probablemente la estructura es muy distinta en grupos clínicos, en los que el énfasis se situará en una o varias escalas depresivas.

B. FIABILIDAD

En una misma muestra de 730 niños de ocho a catorce años se calculó la fiabilidad o consistencia interna mediante la formulación de Kuder-Richardson (K-R 20), y los índices r_{xx} resultantes se han incorporado a la misma tabla 4 porque de alguna manera están relacionados con la variabilidad de la atracción que los elementos han tenido para los sujetos de la muestra. En este tipo de instrumentos de medida (de valoración subjetiva) y dada la pequeña longitud de las escalas (entre 7 elementos en PM y 10 elementos en PV), puede considerarse que los índices de consistencia encontrados son satisfactorios. Como el CDS puede presentarse como un cuestionario de dos grandes subescalas, Depresiva y Positiva (TD y TP), se calcularon también los coeficientes K-R 20 en estos dos totales y los índices r_{xx} encontrados fueron, respectivamente de 0.91 y 0.69, lo cual permite concluir que el CDS presenta un buen nivel de estabilidad o consistencia interna.

En un grupo de 111 niños de 5º y 6º de EGB se pudo lograr una segunda aplicación del CDS un año después del primer examen (cuando los sujetos cursaban 4º y 5º respectivamente). Los resultados de este retest fueron utilizados para obtener índices r_{xx} de estabilidad, a pesar de que las variables mediadas por el CDS pueden ser más estados que rasgos de personalidad, es decir, pueden verse modificados por las situaciones ambientales o personales del sujeto, sobre todo cuando el intervalo de tiempo es grande. En el presente caso el intervalo ha sido de un año, bastante amplio cuando se tiene en cuenta que la personalidad de los sujetos se está formando en esas edades. Los coeficientes de fiabilidad fueron: 0,37 en AA; 0,41 en RA; 0,39 en PS; 0,39 en AE; 0,38 en PM; 0,52 en SC; 0,33 en DV; 0,47 en PV 0,51 en TD; y 0,48 en TP.

En estos coeficientes se observa un descenso en relación con los obtenidos con la fórmula KR-20 y en una muestra más heterogénea; esto puede ser debido, además de a la homogeneidad de la presente muestra a que el intervalo entre el test y el retest es bastante grande para la estabilidad de una variables que son más de tipo estado que rasgo y en una época del proceso de maduración en que la personalidad está conformándose. En todo caso, en el examen de las relaciones entre las variables de depresión en el

Tabla 4
Índices de atracción, e elementos y escalas del CDS (N = 740)

Nº	AA	Nº	RS	Nº	PS	Nº	AE	Nº	PM	Nº	SC	Nº	DV	Nº	PV
1	1,96	2	2,69	3	2,41	4	2,65	5	2,84	6	2,87	7	4,05	8	2,13
9	2,05	10	1,79	11	3,08	12	2,92	13	3,89	14	3,22	15	3,88	16	2,15
17	1,95	18	2,22	19	2,74	20	2,39	21	2,83	22	3,80	23	3,16	24	1,63
25	1,88	26	2,49	27	2,40	28	2,33	29	3,94	30	3,25	31	2,91	32	2,39
33	1,96	34	2,27	35	2,91	36	2,72	37	2,30	38	2,64	39	4,30	40	2,37
41	1,99	42	2,39	43	2,60	44	3,13	45	2,45	46	3,49	47	2,87	48	3,06
49	2,78	50	3,14	51	2,42	52	2,86	53	2,45	54	3,13	55	3,70	56	2,77
57	2,78	58	2,03	59	2,50	60	3,49			61	3,57	62	2,58	36	1,61
														34	2,45
												66	3,53	35	1,97
Prom.	2,17		2,38		2,63		2,81		2,74		3,25		3,44		2,25
r _{xx}	0,61		0,71		0,72		0,74		0,58		0,67		0,56		0,51
Media	17,48		19,05		21,01		22,45		19,21		25,67		30,99		22,51
D.t.	4,37		6,11		6,24		6,21		5,24		5,98		5,60		5,26

test y en el retest se observa una estructura similar y, además, la mayor de las correlaciones entre una subescala de la aplicación del test y todas las subescalas de aplicación retest es la que señala el coeficiente de fiabilidad (es decir, la relación entre AA en momento 1º y AA en momento 2ª es mayor que cualquiera de las correlaciones entre AA en momento 1º y el resto de las variables en momento 2º).

En los estudios de R.B. Cattell sobre la personalidad se alude a la depresión como una variable de tipo estado (transitorio y afectada por las condiciones ambientales my personales del sujeto), y los coeficientes apuntados en este apartado son una corroboración o consecuencia de ese hecho: no es esperable una elevada estabilidad de las medidas de depresión porque su existencia y manifestación están infladas por la situación que rodea al sujeto.

C. VALIDEZ; RELACIONES CON OTRAS PRUEBAS Y VARIABLES

Aunque la información más importante sobre un instrumento viene indicada por su posibilidad de predicción en algún campo importante de la conducta, el grado en que sus medidas se correlacionan con otras pruebas arroja una luz adicional sobre su naturaleza y características.

En una muestra de 193 niños (123 varones y 70 mujeres) de 5º y 7º de EGB, se pusieron en relación las variables del CDS con las escalas de personalidad apreciadas por el Cuestionario EPQ-J de Eysenck (TEA Ediciones, 1978). En la tabla 5 se incluyen los índices de correlación (en centésimas y sin la coma y cero decimales), con los estadísticos básicos (media y desviación típica) de la muestra en ambos instrumentos; en esta muestra los valores críticos de significación (al 5 y 1 por 100, respectivamente) son de 0,142 y 0,187, y el examen de la tabla muestra claramente que todos los aspectos depresivos, excepto el conjunto variado de elementos PV, se relaciona positivamente con la inestabilidad de la personalidad (escala N del EPQ-J). Además es muy interesante en este estudio el hecho de que la incapacidad en estos niños de vivenciar los aspectos positivos (AA, PV y el total TP) se correlaciona con la escala de Sinceridad (convencionalismo o deseabilidad social), tal vez porque los sujetos más sinceros, es decir, más socializadamente sinceros notaran más esa incapacidad de gratificación positiva; esto podría explicar las pequeñas correlaciones negativas de AA (Ánimo-alegría) y PS (Problemas sociales) con la Extraversión.

Tabla 5
Correlaciones entre las escalas del CDS y los factores de personalidad del EPQ-J (N = 193)

	AA	RA	PS	AE	PM	SC	DV	PV	TD	TP	Media	D.t
N	20	44	33	34	42	26	41	10	45	17	12,28	4,06
E	-12	00	-12	-02	06	00	00	01	-02	-05	17,70	4,49
P	06	01	-02	-03	18	01	-05	-13	02	-06	3,20	2,93
S	26	06	-06	02	19	-02	12	18	06	25	9,74	4,82
Media	18,32	18,55	20,94	22,65	19,73	26,24	30,71	22,95	138,82	41,27		
D.t	4,26	6,18	6,28	6,90	5,18	6,04	5,88	5,57	29,28	8,38		

En una fase siguiente de los análisis para la adaptación, se estudio la influencia de la edad y el sexo en las puntuaciones del CDS. Se tomó una muestra de 435 sujetos de 4º, 5º y 7º de EGB y su distribución en el cruce de ambas variables es la siguiente:

EDAD	VARONES	MUJERES	TOTAL
9 AÑOS	88	56	144
10 AÑOS	121	59	180
11 AÑOS Y MÁS	106	5	111

Como ya han indicado las autoras originales del CDS, no se observan diferencias entre los sexos, excepto en las escalas positivas (AA y PV), y sólo en el grupo de los nueve años: las niñas presentan una mejor estructura en los rasgos medidos (puntuán menos en esas escalas positivas). En cuanto a la edad, en general, se observa lo siguiente:

- En las subescalas de tipo negativo y su total TD, disminuyen las puntuaciones al aumentar la edad; los niños mayores son menos “depresivos” (o bien, al ser más conscientes, se muestran cautelosos y lo ocultan).
- En las subescalas de tipo positivo (incapacidad para vivenciar os valores positivos), las puntuaciones aumentan con la edad, lo cual viene a indicar la existencia de más problemas en esta área en los niños mayores. En términos de centiles (según los baremos generales que presentan este manual), y en el Total Positivo, los niños de nueve años obtienen un centil de 40 y los de trece y más años un centil de 65.

Finalmente las variables del CDS se han puesto en relación con los aspectos antisociales y delictivos medidos mediante el Cuestionario A-D (Seisdedos, TEA Ediciones, en una muestra de 129 niños de 51 y 6º de EGB en un centro escolar de los suburbios madrileños (donde, en ocasiones, se detectan problemas de conducta antisocial). Los promedios en el Cuestionario A-D no superan significativamente los obtenidos por la muestra de control con la que se elaboró el instrumento, y los estadísticos en el CDS tampoco se diferencian de los que presentan los baremos de este Manual. La distribución de frecuencias de la variable Antisocial (A) es bastante simétrica en torno a reconocer ocho o nueve faltas antisociales de las 20 que presenta el instrumento, mientras que la distribución de la variable Delictiva (D) es muy asimétrica positiva y pocos niños admiten haber cometido más de dos delitos de los 20 que presenta el A-D. Con todo tal vez resulte interesante examinar las interrelaciones entre estas dos variables y las del CDS; se encuentran en la tabla 6 en centésimas, sin cero ni como decimales.

El examen de las correlaciones de la tabla 6 parece mostrar que la conducta Antisocial (A) se relaciona significativamente con los aspectos depresivos negativos del CDS (sobre todo la respuesta afectiva RA y las preocupaciones hipocondriacas PM y, consecuentemente el total TD). Sin embargo, la conducta Delictiva (D), aunque bastante relacionada con la anterior (0,53), no muestra en los niños una elevación sustancial del fenómeno depresivo; incluso, esa pequeña relación probablemente se anularía si se modulara la conducta delictiva de lo antisocial que lleva consigo. En un intento de probar esto, la muestra de estudio (N = 129) se clasificó en nueve grupos, atendiendo a su poca (A-), media (A=) o mucha (A+) conducta antisocial, y a su poca (D-), media (D=) o mucha (D+) conducta delictiva, y se calcularon los promedios obtenidos por esos grupos en el CDS. En la base de la tabla 6, además de los estadísticos generales de la muestra de estudio (Media, D.t), se han incluido las medias de 4 grupos extremos: los 14 casos que superaban la media de la variable delictiva, es decir, D+; 27 casos A-D-; 15 casos A+D- y 15 casos A+D+.

Estos resultados parecen corroborar o indicado anteriormente pues los aspectos depresivos negativos (sobre todo TD) se elevan sustancialmente al aumentar la conducta antisocial, y en mayor medida cuando lo delictivo es bajo o nulo (D-), como si el fenómeno delictivo hiciera a los sujetos más “duros” e independientes del fenómeno depresivo y las faltas antisociales que cometen los A+ D+ no les afectarían ya. Probablemente esto tiene que ver con la interiorización socialmente de los sentimientos de culpabilidad cuando el sujeto no es

Tabla 6
Relaciones entre los aspectos depresivos y la conducta antisocial y delictiva (N=129)

	AA	RA	PS	AE	PM	SC	DV	PV	TD	TP	A	D
A	08	31	20	20	32	22	21	10	30	11	-	53
D	09	19	01	07	19	15	04	09	13	10	53	-
Media	17,95	19,91	21,09	21,02	20,28	23,10	30,13	22,93	135,60	40,88	8,41	1,25
D.t	4,56	6,35	5,88	6,35	4,99	6,56	6,05	5,07	29,93	8,16	4,58	2,96
D+	18,07	21,93	21,64	21,71	22,43	24,43	30,14	23,07	142,29	41,14	14,43	8,35
A+ D-	17,5	18,22	19,93	19,63	18,78	20,56	28,52	23,00	125,63	40,56	2,70	0,00
A+ D-	16,13	23,80	24,47	23,80	20,93	26,00	32,80	22,40	151,80	38,53	12,47	0,00
A+ D+	20,00	22,67	21,20	22,33	23,33	23,93	30,27	24,33	143,73	44,33	16,33	7,27

asocial, aunque cometa faltas antisociales.

D. ESTRUCTURA INTERNA: ANÁLISIS FACTORIALES

Una primera muestra de 430 niños fue clasificada en tres grupos de edad: hasta nueve años, diez años y más de diez años, y las puntuaciones directas en las ocho subescalas del CDS se sometieron a diversos análisis factoriales (principalmente de tipo oblicuo) para obtener factores principales. En general, se han obtenido dos dimensiones generales, que podrían definirse como Depresión y Tristeza (falta de los aspectos positivos, AA y PV). Esta estructura factorial se mantiene con el paso de los años pero se observan algunos interesantes cambios al aumentar la edad:

- Crece el peso de la falta de autoestima (AE) en lo Depresivo
- Disminuye el de las preocupaciones hipocondríacas (PM) en lo Depresivo y aumentan en la Tristeza.
- Los sentimientos de culpabilidad (SC) reparten su varianza entre ambos factores (pero es negativa en tristeza); parece una relación curvilínea, y el peso en Tristeza disminuye en los niños mayores y se traslada a lo Depresivo.

En la tabla 7 indica sólo las saturaciones factoriales superiores a 0,250; están expresadas en milésimas, y en la base se encuentran los porcentajes de varianza común total explicada por cada factor.

Tabla 7
Estructural factorial en tres grupos de edades

	Factor Depresivo			Factor Tristeza		
	8-9	10	11+	8-9	10	11+
AA				818	716	889
RA	803	826	804			
PS	794	839	784			
AE	776	834	864			
PM	743	705	429			474
SC	589	616	833	-420	-464	-255
DV	742	809	732			
PV				834	818	747
VT %	42	46	43	20	20	21

Cuando en esos tres grupos de edades anteriormente citados se sometió a análisis factorial la matriz de intercorrelaciones (de orden 66) de los elementos del CDS, se obtenían entre 9 y 12 factores cuyas raíces latentes eran superiores a la unidad, que explicaban entre un 38% y un 45% de la varianza común total; sin embargo, cuando se aplicaba el “scree test” el número de dimensiones quedaba alrededor de tres, naturalmente, con una pérdida de la varianza explicada. En general, se observa una agrupación coherente de los elementos (aunque no exactamente en la forma que han indicado las autoras del CDS); así, por ejemplo, algunos elementos de AA se reúnen con otros de PV para formar un factor, mientras que el resto de AA se reúne con el resto de PV para definir otra dimensión que, naturalmente, correlaciona significativamente con la anterior. En esta compleja estructura factorial, diferenciada por grupos de edades, se observa la falta de unas variables criterios que diferencien y aglutinen las covarianzas de los elementos.

Por esto mismo, y aunque con ello se ha introducido una covarianza espúrea (debida a la correlación de los elementos con la escala de que forman parte), en el siguiente paso de los análisis factoriales realizados en los tres grupos de edades se introdujeron las ocho subescalas al lado de los 66 elementos. En estos análisis, la cuantía de las raíces latentes y la aplicación del “scree test” aconsejó reducir el resultado a una estructura bidimensional, y en los tres grupos de edades han surgido con mayor nitidez las dimensiones Depresión y Tristeza indicadas anteriormente. Para ilustrar y especificar lo señalado al comentar los resultados del análisis factorial de las escalas, en la tabla 8 se han incluido los siete elementos de la subescala de tipo hipocondríaco (PM), y en el margen derecho se señalan, en centésimas las saturaciones de estos elementos en las dos dimensiones, Depresión y Tristeza, en los tres grupos de edad indicados con las letras A, B y C (menos de nueve, diez y más de diez años de edad, respectivamente). El lector puede comprobar, ahora a nivel de elemento, la observación anterior de que, con el paso de los años, “disminuye el peso de las preocupaciones hipocondriacas en lo Depresivo y aumentan en la Tristeza”

Finalmente, en una muestra de 193 niños se analizaron conjuntamente los 66 elementos del CDS con las puntuaciones de los sujetos en un cuestionario de personalidad (EPQ-J de Eysenck) que mide Inestabilidad (N), Extraversión (E), Dureza (P) y sinceridad (S). Este análisis factorial parece venir a mostrar que, aunque la Depresión mantiene relaciones con la personalidad, apuntan a dimensiones diferentes, aunque no independientes; ambos aspectos de la conducta (depresión y personalidad) aluden a estratos separados.

En el análisis se obtuvieron cuatro factores; el I y III son los del área de la depresión medida por el CDS (Depresión y Tristeza), mientras que el II y el IV muestran las conexiones de la depresión con la personalidad; están definidos de la siguiente forma:

1. La Depresión, con peso en la mayoría de los elementos de tipo depresivo; también saturan algunos elementos positivos (lo que explica su relación con la segunda dimensión en la depresión), pero tienen igual o mayor peso en el factor III
2. Lo inestable (N) de la depresión; señala las conexiones entre el CDS y la personalidad
3. La tristeza, relacionada con la falta de Sinceridad (S-)
4. Lo inestable (N), duro o agresivo (P) y sincero (S) del polo negativo de la Tristeza.

Si en este análisis no se han definido con mayor nitidez los rasgos de la personalidad, ha sido porque no existían suficientes variables en esta área (sólo cuatro frente a las 66 de la depresión); en esta inferioridad de equilibrio, las de personalidad no definen vectores separados y únicamente vienen a señalar conexiones.

Tabla 8
Saturaciones de los elementos de PM en dos dimensiones

Número de orden y redacción del elemento	DEPRESIÓN			TRISTEZA		
	A	B	C	A	B	C
5. Me despierto a menudo durante la noche	23	21	07	-08	-01	-33
13. Me siento más cansado que la mayoría de los niños que conozco	34	38	29	-09	-05	-15
21. La mayoría del tiempo no tengo ganas de hacer nada	37	32	20	-08	-20	-38
29. Muchas veces me dan ganas de no levantarme por las mañanas	37	13	-03	-06	07	-24
37. Muchas veces me siento muerto por dentro	36	62	54	-00	-11	-21
45. Estando en el colegio me siento cansado casi todo el tiempo	50	33	28	-22	-21	-40
53. A menudo imagino que me hago heridas o me muero	53	50	35	01	-14	-01

3.3 SALUD MENTAL, DEPRESIÓN Y OTRAS VARIABLES DE LA PERSONALIDAD

“ En el campo de la salud mental infanto-juvenil se ha mostrado que una línea constante de trabajo es la que se centra en abordar la asociación que con el fenómeno tienen las implicaciones de medio en el cual éste interactúa” (Pulido y Cabaco 1988; Jimenez y Cabaco 1991).

En un estudio con 682 alumnos de 8 de EGB de la provincia de Salamanca se han realizado varios análisis para delimitar cómo afecta a la manifestación de la depresión el medio de resistencia (rural/urbano), el sexo y otras variables del sujeto; la inadaptación, la ansiedad, los rasgos de personalidad y el clima o ambiente escolar y familiar (Cabaco 1994).

En una muestra de 205 varones y 377 mujeres; 267 viven en la capital y 415 en distintos núcleos poblacionales de la provincia; 389 (57%) tienen 13 años, 185 (27%) tienen 12 años y 108 (16%) tienen 14 años.

En el CDS se han tomado únicamente los Totales Positivos (TP) y Depresivos (TD). Para evaluar la adaptación se ha usado el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI, de P. Hernández 1983), con las escalas de inadaptación personal (P), escolar (E), social (S), familiar (F), hermanos (H), pro-imagen (I) y una medida de contradicciones (C). La medida de la ansiedad (mediante el Inventario STAI de C.D. Spielberg y cols. TEA Ediciones) ha contado con dos apreciaciones (E y R, estado y rasgo) de este constructo.

Las variables de personalidad han sido apreciadas mediante el Cuestionario HSPQ (R.B. Cattell) con 14 escalas. El clima familiar ha sido apreciado mediante las dimensiones de Relaciones, Desarrollo y Estabilidad, y el clima escolar mediante las dimensiones Relaciones, Autonomía, Estabilidad y Cambios de las Escalas FES y CES, respectivamente.

En cuanto al CDS, la muestra tiene un perfil mejor que el grupo normativo del presente manual, es decir, una puntuación significativamente más alta (centil 95) en los aspectos positivos (TP) y más baja (centil 33) en los aspectos depresivos (TD). Atendiendo a este mejor perfil de salud mental, se ha considerado conveniente elaborar unos baremos con esta muestra de escolares salmantinos, y se incluyen a continuación de la normativa elaborada hace años con niños de 8 a 15 años de procedencia diversa.

Analizada la influencia del medio de resistencia y del sexo se observan diferencias estadísticamente significativas (sólo en el valor TD) a favor de un perfil mejor en el medio urbano y entre los varones; sin embargo, las diferencias no son empíricamente tan grandes como para aconsejar una tipificación separada y los baremos se han elaborado reuniendo los niños de los ambientes rural y urbano, y de ambos sexos.

El análisis de las intercorrelaciones de las 1 variables de este estudio ha permitido conocer que la influencia de las variables de las áreas medidas (personalidad, adaptación, ansiedad y clima escolar/familiar) se manifiesta únicamente en el Total Depresivo (TD) del escolar. Atendiendo a su grado de significación estadística, a continuación se presentan las características de dichas áreas que muestran alguna incidencia en un niño depresivo, y entre paréntesis se recoge el índice de correlación observado; dichas características definen a un niño;

- Personalidad: emocionalmente inestable (-0,42), aprensivo (0,39), cohibido (-0,32), poco integrado (-0,25), tenso (0,25), excitable (0,24), despreocupado (-0,23), poco sociable (0,17), dubitativo (0,14), sensible (0,3), reservado (-0,10) y sumiso (-0,10)
- Adaptación: inadaptado en lo personal (0,61), social (0,32), escolar (0,28), con los hermanos (0,26) y familiar (0,22), y poca autoimagen (-0,23).
- Ansiedad: ansioso, más a nivel de rasgo (0,54) que de estado (0,37);
- Clima: de pobres relaciones, tanto en el marco familiar (-0,18) como en el escolar (-0,14).

En el análisis factorial de las 31 variables, los aspectos depresivos del CDS se alinean en una primera dimensión general de tipo ansioso/depresivo; junto al TD están las dos medidas de ansiedad (Estado y Rasgo del STAI), la inadaptación personal (TAMAI-P) y la Aprensión (HSPQ-O)

Cuando se repite el análisis anterior incluyendo únicamente las medidas más clínicas (HSPQ, STAI y CDS), el primer factor es más claramente de tipo ansioso/depresivo y, además de las anteriores (excepto, obviamente, la medida TAMAI-P), se añaden características de un niño afectado por los sentimientos (HSPQ-C) y despreocupado o desatento con las normas (HSPQ-G). Como la estructura factorial pedida es de tipo oblicuo, este factor muestra una correlación de 0,36 (muy significativa por darse entre vectores factoriales) con otra dimensión de Inestabilidad que definen a una persona turbable, tensa aprensiva y cohibida.

En resumen, el presente estudio muestra las conexiones que tiene la depresión con la salud mental del escolar, junto a las variables de ansiedad, personalidad, inadaptación y clima escolar/familiar. Por tanto, una mejor evaluación de la problemática de los escolares aconseja la utilización de otros instrumentos al lado del CDS.

4. NORMAS INTERPRETATIVAS

4.1 MUESTRA GENERAL DE TIPIFICACIÓN

Dentro de la muestra de tipificación (compuesta por más de 900 casos de niños de ocho a catorce años), hubo que desechar algunos incompletos y los utilizados con retest para el análisis de fiabilidad. Los 843 sujetos resultantes se agrupaban por sexo y edad, tal como indica la tabla 9 que viene a continuación.

En determinados análisis, esta muestra general se clasificó en tres grupos de edades (manteniendo separados ambos sexos en algunos casos): 274 niños de ocho – nueve años, y 206 de doce y más años. A partir del momento en que se observó la poca o nula incidencia de la variable sexo, se unieron ambos para continuar los estudios, y, al final, cuando se determinó también la pequeña influencia de la variable edad, esta muestra general se trató como un todo, sobre todo a la hora de elaborar los baremos para interpretación.

Tabla 9
Muestra de tipificación clasificada por sexo y edad

SEXO	EDADES							Totales
	8	9	10	11	12	13	14	
Varones	17	167	218	43	93	60	17	615
Mujeres	24	66	72	18	28	17	3	228

4.2 CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS EN PUNTUACIONES TRANSFORMADAS

Aunque en los estudios originales se ha empleado la escala de los deciles para interpretar las puntuaciones directas, en la tipificación española se ha preferido obtener las puntuaciones transformadas en las escalas de centiles y decatipos, presentadas en paralelo en la tabla 10.

La puntuación centil indica el tanto por ciento del grupo normativo al que un sujeto determinado es superior en la variable apreciada por el instrumento; los centiles no forman una escala típica, sino ordinal, y no pueden emplearse para calcular promedios con los centiles obtenidos en otras variables.

Las puntuaciones decatipos constituyen una escala típica de diez puntos (media= 5,50, desviación = 2), que puede ser fácilmente comprendida por el público en general. En los decatipos centrales (5 y 6) queda comprendido el 40 por ciento medio; si el alejamiento de la media fuese algo mayor, dentro de los decatipos 4, 5, 6 y 7 se encuentran los dos tercios (en realidad 68,26 por ciento) de una distribución, lo cual se considera el grupo promedio; los decatipos de la media, y, por último, los decatipos 1 y 10 son valores extremos; todas estas posiciones se entienden de modo relativo a la población específica sobre la cual se realizó la tipificación.

Una vez obtenidas las puntuaciones directas mediante el uso de la plantilla de corrección aplicada a la Hoja de respuestas, es fácil buscar en la tabla la columna correspondiente a la escala o subescala a interpretar. En cada columna se buscará la puntuación directa obtenida por el sujeto y, a la misma altura, horizontalmente, se encontrará; la puntuación centil en la primera columna de la izquierda y la puntuación decatipo en la columna de la derecha de la tabla.

Cuando una puntuación directa no aparezca expresamente indicada en la tabla, debe hacerse una interpolación y asignarle un centil o decatipo comprendido éntrelos correspondientes a los valores inmediatamente superior e inferior registrados. No ha parecido conveniente el uso de todos los centiles, pues con ello se daría la impresión de una excesiva exactitud que el error de medida de la prueba no garantiza, además de los deciles y los centiles extremos, únicamente se han incluido aquellos centiles que ayudan a definir el ámbito de los decatipos correspondientes.

4.3 GRUPOS CLÍNICOS

Las puntuaciones directas obtenidas en el CDS por un sujeto o grupo que ha sido definido (apriorísticamente o mediante la utilización de otras técnicas) dentro de un determinado grupo clínico, pueden interpretarse acudiendo al uso de:

- a) Un baremo de población general normal.
- b) Un baremo específico del mismo grupo clínico

En el primer caso, el psicólogo clínico espera un perfil de alejamiento (valles y crestas) característicos del determinado grupo clínico al que pertenece el sujeto, y la cuantía de esos alejamientos le indicará la gravedad o mejoría del examinado. Utilizando un baremo general se pueden comparar sujetos o grupos de igual o distinta nosología clínica, puesto que la base comparativa es la misma (una supuesta normalidad).

En el segundo caso (baremo específico elaborado con una muestra claramente definida dentro del grupo clínico), bastará un perfil horizontal obtenido con puntuaciones directas iguales a los promedios para señalar la pertenencia del sujeto a ese grupo clínico, pero un perfil bajo no indicará necesariamente la inexistencia de problemas depresivos, puesto que el perfil puede resultar medio o alto si se emplea un baremo específico de otro grupo clínico distinto del anterior.

Este segundo enfoque exigiría disponer de varios baremos específicos para diagnosticar un caso que se presenta por primera vez, y tenerlos a mano en las distintas fases del tratamiento para conocer las posibles derivaciones que vaya teniendo el problema (no siempre o directamente hacia la normalidad).

4.4 BAREMOS ESPECÍFICOS

La muestra empleada en el estudio de la salud mental (apartado 3.3) ha facilitado la elaboración de unos baremos específicos con 682 niños de ambos sexos de 8º de EGB. Sin embargo, en esta ocasión solo se han tipificado los Totales Depresivos y Positivo del CDS, y los resultados se encuentran en la tabla 11.

En el margen izquierdo de estos baremos se ha introducido la escala de centiles descrita anteriormente. En el margen derecho se ha empleado la escala típica de puntuaciones “S” que permite mayor dispersión que la escala de decatipos usada en la tabla 10; su media se sitúa en el valor 50 y tienen una desviación típica de 20 puntos; por tanto, el grupo promedio (el que comprende los dos tercios de una población estadísticamente normal) indicado en un apartado anterior, se encuentra entre las puntuaciones “S” 30 y 70.

TABLA 10
BAREMOS

Muestra general de tipificación, ocho-quince años, varones y mujeres

Centiles	Puntuaciones directas										Decatipos
	AA	RA	PS	AE	PM	SC	DV	PV	TD	TP	
99	29-40	34-40	36-40	32-40	32-35	39-40	43-45	36-50	208-240	63-90	10
97	26	32	33	35	30	38	41	34	190-193	57	9
96	-	31	32	34	29	37	-	33	187-189	56	9
95	25	30	31	33	28	36	40	32	184-186	55	9
90	24	28	30	31	27	34	38	30	174	51	8
85	22	26	28	29	25	32	37	28	167	48	8
80	21	25	27	28	24	31	36	27	161	47	7
75	20	23	-	26	-	30	35	-	156	45	7
70	-	22	25	25	22	29	34	25	152	44	7
65	19	21	24	-	21	-	-	-	148	43	6
60	-	20	23	24	20	28	33	24	145	42	6
55	-	19	22	23	-	27	32	23	142	41	6
50	18	18	21	22	19	26	31	22	136	40	6
45	17	-	20	-	18	25	-	-	134	39	5
40	-	17	19	21	-	24	30	21	130	37	5
35	16	16	18	20	17	-	29	20	127	36	5
30	15	15	17	19	15	23	28	-	123	35	4
25	-	-	-	18	-	22	-	19	119	-	4
20	14	-	15	17	-	21	26	18	114	33	4
15	13	13	14	16	14	20	25	17	109	32	3
10	12	11	13	14	12	18	23	16	102	30	3
5	11	10	11	12	11	16	22	15	94	28	2
4	10	9	10	11	10	15	21	14	93	27	2
1	0-9	0-8	0-8	0-9	0-9	0-11	0-16	0-12	0-75	0-22	1
N	843	843	843	843	843	843	812	819	812	819	N
Media	17,48	19,05	21,01	22,45	19,21	25,97	30,99	22,51	138,51	40,01	Media
D.t	4,37	6,11	6,24	6,21	5,24	5,98	5,60	5,26	27,79	8,28	D.t

TABLA 11**BAREMOS**

Totales Depresivos (TD) y Positivos (TP) en 8° de EGB

Pc	Puntuaciones Directas		S
	TD	T	
99	191-240	85-90	97
98	184-190	82-84	91
97	178-183	79-81	87
96	177	-	85
95	169-176	75-78	83
90	160-168	71-74	76
85	153-159	69-70	71
80	148-152	66-68	67
75	143-147	64-65	63
70	139-142	62-63	60
65	135-138	61	58
60	131-134	59-60	55
55	127-130	57-58	52
50	123-126	55-56	50
45	120-122	54	48
40	116-119	52-53	45
35	112-115	50-51	42
30	107-111	48-49	40
25	102-106	46-47	37
20	97-101	44-45	33
15	91-96	41-43	29
10	82-90	37-40	24
5	74-81	34-36	17
4	71-73	32-33	15
3	66-70	30-31	12
2	60-65	28-29	9
1	0-59	0-27	3
N	682	682	N
Media	124,80	55,78	Media
D.t	30,12	13,21	D.t